Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

SENTENÇA

Autos 0801445-82.2025.8.12.0018
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: José Augusto da Silva Carvalho
Réu: Bensaúde Plano de Assistência Médica Hospilar Ltda

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar ajuizada por José Augusto da Silva Carvalho, representada por sua genitora *Jessica Samanta Souza Silva*, em face de Bensaúde Plano de Assistência Médica Hospilar Ltda, ambos qualificados nos autos, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que foi diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1, patologia compatível com o CID E10, sendo que desde os nove anos de idade vem realizando várias aplicações diárias de insulina. Explica que tem frequentes crises de hiper e hipoglicemia, razão pela qual o médico responsável pelo seu tratamento receitou a utilização de bomba de insulina e insumos, a fim de evitar complicações crônicas do diabetes. Ressalta que solicitou a disponibilização do aludido equipamento junto ao plano de saúde réu, contudo teve seu pedido negado. Aduz que a negativa da parte ré mostra-se incorreta, diante da necessidade do tratamento e, assim discorrendo, pugnou pela concessão de liminar, para o fim de compelir a parte ré a fornecer ao autor bomba de insulina e insumos, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária. Protestou pela produção de provas, deu valor à causa e juntou documentos.

A liminar foi deferida, conforme decisão de f. 44/49.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 31/07/2025 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801445-82.2025.8.12.0018 e código k11Czont.

A parte ré foi citada e ofertou contestação nas f. 92/101. No mérito, discorreu sobre os limites da obrigação contratual. Asseverou sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Alegou que o procedimento não está previsto no rol da ANS. Discorreu sobre o princípio da isonomia e alegou a ausência de dano moral indenizável. Pugnou pelo julgamento improcedente dos pedidos.

Impugnação à contestação nas f. 132/136.

Intimadas para especificação de provas, a parte autora pugnou pela juntada de documento, enquanto a parte ré pugnou pela produção de prova pericial e documental (f. 144).

O Ministério Público ofertou parecer nas f. 175/177, opinando pela realização de perícia médica.

É o relatório. DECIDO.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar ajuizada por José Augusto da Silva Carvalho, representada por sua genitora *Jessica Samanta Souza Silva*, em face de Bensaúde Plano de Assistência Médica Hospilar Ltda, ambos qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a existência da patologia e a necessidade do procedimento indicado na prefacial restaram incontroversos, visto que não impugnada pela parte ré em sede de contestação.

Logo, a controvérsia destes autos refere-se ao dever contratual da parte ré em autorizar o procedimento pleiteado pelo autor, tratando-se de matéria essencialmente jurídica, que dispensa a realização da prova técnica.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 31/07/2025 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801445-82.2025.8.12.0018 e código k11Czont.

Por tais razões, indefiro o pedido de produção de provas formulado pelas partes e Ministério Público, sendo o caso de julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia acerca do dever da parte ré em fornecer o equipamento denominado "bomba de insulina e insumos".

A parte ré sustentou que o tratamento não se encontra previsto no rol da ANS, bem como que o procedimento não era de urgência.

Compulsando os autos, entendo que o pleito autoral comporta acolhimento.

Inobstante as alegações da parte ré de que o tratamento não se encontra previsto no Rol da ANS, anoto que a Lei n.º 9.658/98 prevê a possibilidade de cobertura caso exista comprovação da eficácia do tratamento:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
> *(...)*
> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico;*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 31/07/2025 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801445-82.2025.8.12.0018 e código k11Czont.

Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

No caso dos autos, o laudo médico de f. 40, não impugnado, indica que o tratamento é o mais moderno para a patologia apresentada pelo autor, apresentando benefícios a curto e longo prazo. Veja-se:

> **Estudos sobre sistema de infusão + sensor são conclusivos , mostrando eficácia em diminuir variabilidade glicêmica, manter glicemia dentro da meta, diminuir HB glicada,e diminuindo glicada é possível evitar complicações micro e macrovasculares**
>
> O tratamento solicitado é o que temos de mais moderno no tratamento de Diabetes mellitus tipo 1 no momento. Teremos benefícios de curto e longo prazo, evitando hipoglicemias e cetoacidose diabética (situações com risco de morte) e postergando/evitando complicações micro e macro vasculares, como cegueira, doença renal crônica, dor e incapacidades por neuropatia diabética, amputações, acidente vascular encefálico ou infarto agudo do miocárdio, entre outras.
>
> Abaixo, a referência de um artigo científico sobre o tema:
>
> ***Real-World Performance of the Minimed™ 780G System: First Report of Outcomes from 4120 Users. Julien Da Silva[1], Giuseppe Lepore[2], Tadej Battelino[3], Arcelia Arrieta[4], Javier Castañeda[4], Benyamin Grossman[5], John Shin[5], Ohad Cohen[1]***
> ***PMID: 34524003 PMCID: PMC8817690 DOI: 10.1089/dia.2021.0203***

Outrossim, o relatório de f. 146/147, não impugnado, demonstra que o tratamento fornecido possibilitou melhora no quadro do paciente.

Conforme extrai-se d Lei n.º 14.454/2022, que incluiu o dispositivo supracitado, é possível inferir que o rol da ANS trata-se de lista que contém o mínimo de procedimentos que as operadoras de saúde são obrigadas a fornecer, não se tratando de rol taxativo. Veja-se o entendimento do c. STJ:

> *CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 31/07/2025 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801445-82.2025.8.12.0018 e código k11Czont.

> *limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.* (STJ - AgInt no REsp: 2034025 SP 2022/0331948-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023) Grifei.

Lembro que, nos contratos de plano de saúde, mais do que nunca, faz-se necessária uma interpretação social, à luz da legislação consumerista e dos princípios constitucionais, notadamente, a dignidade da pessoa humana. A doutrina destaca o seguinte entendimento sobre o tema:

> *"(...) Quem quer contratar plano de saúde quer cobertura total, como é obvio. Ninguém paga plano de saúde para, na hora em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo tratamento sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber e não prestar o serviço pretendido pelo consumidor (...)"* (NELSON NERY JÚNIOR *in* Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 8ª Edição, página 570). Grifei.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 31/07/2025 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801445-82.2025.8.12.0018 e código k11Czont.

> *"(...) Em matéria contratual, não mais se acredita que assegurando a autonomia da vontade e a liberdade contratual se alcançará, automaticamente, a necessária harmonia e equidade nas relações contratuais. Nas sociedades de consumo, com seu sistema de produção e de distribuição em massa, as relações contratuais se despersonalizaram, aparecendo os métodos de contratação estandardizados, como os contratos de adesão e as condições gerais do contrato. Hoje esses métodos predominam em quase todas as relações entre empresas e consumidores, deixando claro o desnível entre os contratantes um autor efetivo das cláusulas, e outro, simples aderente. É uma realidade social bem diversa daquela do século XIX, que originou a concepção clássica e individualista do contrato, presente em nosso Código Civil de 1917"* (Cláudia Lima Marques: in Novas regras sobre a proteção do consumidor nas relações contratuais, Revista de Direito do Consumidor, n. 1, pág. 27).

Ressalte-se que o pedido da autora de maneira alguma afronta o princípio contratual do *pacta sunt servanda*, isto porque o alcance do referido princípio restou atenuado e reduzido, especialmente quando está em discussão interesse individual relacionado à dignidade da pessoa humana, aliás, como ocorre no caso em apreço.

Percebe-se que, muitas vezes, os planos de saúde oferecem muitas vantagens, usando como argumento as notórias deficiências e limitações do Sistema Único de Saúde, porém, no momento de efetiva prestação de serviço impõe óbices instransponíveis, deixando aos cuidados do sistema público de saúde o custeio de intervenções de alto custo e complexidade.

Evidente está a ofensa à boa-fé objetiva, visto que a autora, em quadro de saúde delicado, beneficiária do plano de saúde, quando se vê em uma situação de necessidade, depara-se com a recusa do atendimento, com base em uma interpretação um tanto obscura das cláusulas redigidas unilateralmente pela parte ré.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 31/07/2025 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801445-82.2025.8.12.0018 e código k11Czont.

Veja-se a jurisprudência sobre o tema:

"(...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA ABUSIVA – RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – ART. 51, CDC – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS – RECURSO IMPROVIDO. (...) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado para declarar nulas as cláusulas abusivas previstas nos contratos de adesão. É vedada a interpretação extensiva de cláusula contratual limitativa de direitos, prevista em contratos de adesão de plano de saúde. (Agravo Regimental em Apelação Cível - Ordinário - N. 2006.013731-2/0001-00 - Relator - Exmo. Sr. Des. Paschoal Carmello Leandro) Grifei.

Assim, demonstrado o dever da parte ré em custear o tratamento, impõe-se a procedência do pleito autoral neste ponto.

Nessa linha de argumentação, reputo inexistentes os danos morais narrados na prefacial, considerando que a recusa de tratamento médico por plano de saúde caracteriza inadimplemento contratual que, em regra, não configura, de *per se*, abalo à esfera anímica da parte.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado do e. TJMS:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – RECURSO VOLUNTÁRIO DA REQUERIDA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO HOME CARE REALIZADO POR DETERMINAÇÃO LIMINAR – REVOGAÇÃO POSTERIOR DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO FATOR DE COPARTICIPAÇÃO – BOA FÉ DO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO DA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 31/07/2025 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801445-82.2025.8.12.0018 e código k11Czont.

AUTORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – COBRANÇAS INDEVIDAS - MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – EQUIDADE – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Descabe falar em cobrança do fato participativo no período em que os serviços foram prestados por força de decisão judicial posteriormente revogada, quando constatada a boa-fé da beneficiária no ajuizamento da demanda. Nos termos do posicionamento do STJ, a negativa de tratamento por parte do plano de saúde ou mesmo a cobrança de valores baseada em interpretação equivocada do contrato não gera abalo extrapatrimonial, cabendo à parte comprovar a ocorrência de fato extraordinário causador de profundo abalo psicológico. (...). (TJMS. Apelação Cível n. 0804398-87.2023.8.12.0018, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j: 29/08/2024, p: 02/09/2024) Grifei.

Assim, deve ser rejeitar a pretensão indenizatória.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na prefacial para o fim de condenar a parte ré a fornecer à parte autora, conforme prescrição médica, o equipamento denominado "bomba de insulina e insumos", sob pena de bloqueio de valores em montante suficiente para custear o tratamento.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando a reduzida complexidade e duração da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas devidas pela parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Resolvo o mérito desta ação, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 31/07/2025 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801445-82.2025.8.12.0018 e código k11Czont.

Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Paranaíba
2ª Vara Cível

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para ofertar contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC. Havendo apelo adesivo (art. 1.010, § 2º, do CPC), intime-se o apelante para apresentar contrarrazões. Após, considerando que o art. 1.010, § 3º, do CPC preconiza que a competência para exercer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação é do juízo ad quem, remetam-se os autos ao e. TJMS para processamento do recurso.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Paranaíba, data da assinatura eletrônica.

Plácido de Souza Neto
Juiz de Direito
Assinado digitalmente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por PLACIDO DE SOUZA NETO, liberado nos autos em 31/07/2025 às 16:25 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0801445-82.2025.8.12.0018 e código k11Czont.